

論述	大陸現況	法今天地	全民國防	資通安全	科技新知	健康生活	生態保育	文與藝	美麗台灣・文化領航	其他
----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----------	----

營養師能夠提供的只是減重的知識及技術，真正執行面還是要靠自己的努力和付出。

淺談骨質疏鬆症

◎蔡婉妮

前言

隨著高齡人口的增加，骨質疏鬆症目前已是僅次於心血管疾病的第二大流行疾病。臨床上，骨質疏鬆症通常是無聲無息地進行，病人大多因為突發性的骨折，引起行動不便或劇烈疼痛而求醫。骨質疏鬆症引起之骨折常發生於腕部、脊椎體及髖部，其中尤以脊椎體及髖部骨折最為嚴重。在臺灣，大約三分之一的婦女在一生中會發生一次脊椎體、髖部或腕部之骨折；男性也約有五分之一的風險。而依健保紀錄，發生髖部骨折的老人，一年內之死亡率女性約為15%，男性則高達22%。死因則以長期臥床引發之感染為主。

認識骨質疏鬆症

美國國家衛生院定義骨質疏鬆症為「一種因骨骼強度減弱致使個人增加骨折危險性的疾病」。大約從30至35歲，人的骨質量便開始減少。尤其女性在更年期之後，雌性激素分泌減少，骨質流失就更快。很多人誤以為只有女性才會有骨質疏鬆症，事實上，不論男女都會發生骨質疏鬆症，但婦女罹患的機會比較高。根據統計，女性罹患骨質疏鬆症的可能性高出男性6至8倍。骨質疏鬆症患者在早期多不自覺，直到發生骨折而可能產生腰痠背痛、行動不便及關節變形。較嚴重的情況是脊椎骨會被壓扁而產生駝背、變矮、下背疼痛等情形；如果脊椎極度彎曲，還會引起呼吸困難。骨質疏鬆症的高危險群包括老年人，尤其是停經後婦女及鈣攝取不足、常食高蛋白、高鹽、菸、酒、少運動、不曬太陽等人。另外某些疾病（如庫欣式症、甲狀腺亢進、副甲狀腺亢進等）或長期服用某些藥劑（如類固醇），也容易導致骨質疏鬆症。骨質疏鬆症的診斷，可以依據骨質密度T值判定，或以X光檢視是否有壓迫性骨折。

骨質疏鬆症的藥物治療

一旦診斷為骨質疏鬆症，應先找出致病因素是原發性（老化、停經等引起）或次發性（疾病、藥物引起），並且對症下藥，才能防止骨質疏鬆繼續擴大。治療骨質疏鬆症，最普遍的方法是服用鈣片。以停經婦女而言，不論是由飲食中，或是額外補充，每天應攝取約1,500毫克的鈣，若能再加上維他命D，就能更進一步促進鈣質的吸收；此外，要多接觸陽光，因為陽光可以促進體內維他命D的合成。

治療骨質疏鬆症的藥物基本上分為兩大類，一類是抑制骨骼溶蝕的藥物，改變破骨細胞在骨骼表面進行的活動，藉以減緩骨質流失的速度。這一類藥物包括荷爾蒙療法、選擇性雌激素受體調節劑、雙磷酸鹽藥物、抑鈣素；另一類是刺激造骨細胞的藥物，加速骨質的生成，如副甲狀腺素。分述如下：

一、雙磷酸鹽藥物：

雙磷酸鹽藥物是目前治療骨質疏鬆、防止骨折的主流用藥。衛生署核准的口服雙磷酸鹽藥物，包括Alendronate（商品名Fosamax，福善美）、Risedronate（商品名Actonel，安妥良），每天或每週吃一次；注射雙磷酸鹽藥物則有Ibandronate（商品名BONVIVA，骨維壯），三個月施打一次，及上市不久的Zoledronic Acid（商品名Aclasta，骨力強），一年注射一針。常見的副作用包括：胃腸不適（例如便秘、吞嚥困難、胸痛）、腹部或肌肉骨骼痛（例如關節痛、背痛）、噁心、心口悶熱或食道發炎。為了降低副作用及確保藥物被充分吸收，通常醫生會建議病人空腹喝一大杯開水吞服藥丸，並在服藥之後，必須保持挺直的姿勢至少30分鐘。

二、荷爾蒙療法：

更年期的女性及卵巢切除的婦女，適當地補充雌激素，能有效防治骨質疏鬆症。然而，罹患乳癌或心血管疾病之高危險群患者，則不宜採用。

三、選擇性雌激素受體調節劑：

這是一種新一代的類雌激素藥物，主要作用在骨骼組織的雌激素接受器上，能仿效雌激素的效益，減少骨質流失，降低骨折發生率，且不會提高乳癌及子宮癌的罹患率。常見的副作用是熱潮紅及腿部痙攣，並有增加靜脈血栓性栓塞的風險。當病患的小腿感到疼痛、腫脹，甚至咳血、視力變化、突然胸痛、氣喘，就要請醫師診治。

四、抑鈣素：

抑鈣素能抑制骨質的分解，降低脊椎骨折的風險，並具止痛效果。目前有兩種型態的藥劑，一種是注射型，另一種為噴鼻劑。噴鼻劑比較常被使用，副作用包括鼻炎、背疼、流鼻血和頭痛。

五、副甲狀腺荷爾蒙：

這是唯一用於治療骨質疏鬆症，特別增加骨質形成（而不是減少骨質損失）的藥物。從副甲狀腺荷爾蒙提煉出來的藥物Teriparatide（Forteo）能刺激造骨細胞，加速骨骼的生成速度。使用這種藥物的人每天需自行注射一劑。一般的副作用包括噁心、腿痙攣、頭暈、疼痛、頭痛、無力、腹瀉和沮喪。如有任何嚴重的症狀，要請醫師診治。嚴重的副作用則有胸痛、昏倒、困難呼吸、發燒、喉嚨痛、寒顫和感染、腸胃不適、嘔吐、便秘、肌肉無力等。在老鼠的實驗中，高劑量使用Teriparatide（人體使用劑量的大約3至60倍）可提高骨肉瘤（一種惡性骨腫瘤）的發生率，因此不能用於患有骨肉

瘤的高危險群，或曾經接受骨骼放射線治療的病患。目前國內健保則規定使用期限不能超過18個月。

六、新藥：

最近核准上市用於治療骨質疏鬆症的新藥，包括一年打一針的長效型雙磷酸鹽藥物「骨力強」（Zoledronic Acid），及具有雙重作用，既可抑制破骨細胞吸收骨頭，造成骨質流失，又能幫助促進骨骼生成的「鋇」（Strontium Ranelate補骨挺疏）等，提供更多元的治療選擇。

雖然目前已有多種藥物可供選擇，但骨質疏鬆症的藥物需要長期規則服用，才能達到治療骨質疏鬆及預防骨折的效果。

骨質疏鬆症的預防

骨質疏鬆症的防治，應及早開始。飲食上，終生應注意攝取充分之鈣質和維生素D。體重不宜過輕，載重式運動如步行等，可增加骨骼量，而菸、酒則會減少骨骼量。對停經後的女性，應分析各種風險因子是否存在；若有明顯之風險因子存在，則應評估其骨質密度。預防骨折，除針對骨骼本身之保健外，絕對需要同時也注意其他的骨折風險因子，包括：保持患者肌肉之力量與協調性、保持病患之平衡感、注意使用易造成危險狀況之藥物（如易造成低血壓、低血糖、暈眩等）、減少環境障礙及校正視力等。另在強調預防跌倒方面，如有需要，病患應使用拐杖、行走輔助器及腕部保護墊等裝置。

結語與展望

隨著高齡人口的逐漸增加，骨質疏鬆症盛行率及社會醫療資源之耗損，恐將繼續攀升，大家不可輕忽這種疾病的重要性，應立即共同加以防治。最後提醒讀者，本文係衛教資料並非治療指引，文中任何資料都不能取代醫師的指導和建議。若您對本身健康或疾病治療上有任何疑問時，應到醫療院所請教醫師。

（作者現為臺中榮總新陳代謝科醫師）

▲Top

論述	大陸現況	法令天地	全民國防	資通安全	科技新知	健康生活	生態保育	文與藝	美麗台灣・文化領航	其他
----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----------	----

食物是最天然、最安全且易吸收的營養補充品，惟嚴重貧血者還需遵循醫囑補充鐵劑，才能達到最佳效果。

缺鐵性貧血與飲食治療原則

◎廖瑞華

貧血是臨床上很常見的問題，貧血的種類繁多且病因各不相同，其中以缺鐵性貧血最常見。缺鐵性貧血是由於缺乏鐵質而造成紅血球的合成有缺陷，使得血液中紅血球內的血色素減少。

造成缺鐵性貧血的原因

一、血液流失：

如女性經血過多、胃腸道出血、惡性腫瘤等，都有可能造成血液流失。

二、鐵質攝取不足或吸收不良：

飲食中鐵質不足如長期吃素者，或因腸胃道疾病，如長期腹瀉或缺乏胃酸而造成吸收不良。

三、鐵的需求量增加：

嬰兒期、青春期、懷孕及哺乳期因對鐵質需求量增加，若無適當補充，亦會造成缺鐵性貧血。

鐵質每日建議量（國人膳食營養素參考攝取量）

一、兒童、男性及更年期女性為10毫克。

二、青春期及至更年期前的女性為15毫克。

三、懷孕第三期及哺乳期除原來之15毫克外，則需額外再增加30毫克。

治療缺鐵性貧血的飲食原則

一、足夠的蛋白質食物來源：

蛋白質是合成紅血球的原料之一，足夠的蛋白質食物來源搭配均衡飲食，以及攝取足夠的熱量才能改善貧血現象。奶製品、肉類、魚類、蛋類和黃豆製品，都是良好的蛋白質來源食物。

二、攝取富含鐵質的食物：

（一）動物性食物來源：最佳鐵質來源是肝臟，其次是牡蠣、內臟類、肉類；肉類中以紅色越深含鐵量越多，如牛肉、豬肉等。

（二）植物性食物來源：包括乾果類如黑棗、葡萄乾等，深綠色蔬菜、紫菜和強化鐵質之早餐穀類食物。

三、促進鐵質吸收的食物：

富含維生素C的食物如柑橘類水果等，與含鐵質的食物同時食用時，有助於鐵質被人體吸收。

四、減少鐵質吸收的食物：

當飲食中高劑量的鈣與鐵同時存在時，可能會抑制鐵的吸收；同時含有過量草酸及植酸的食物，和茶葉中的單寧亦會減少鐵質的吸收，應避免與富含鐵質的食物同時食用。

鐵質的吸收除與食物中的含量有關外，也與鐵質的吸收率相關。在正常狀況下，飲食中鐵質的吸收率約為10至15%，也有研究認為介於1至40%之間。人體對鐵質的需求程度會直接影響鐵質的吸收率，其他如鐵質的化學型態也會影響鐵質的吸收，如存在動物性食物中的血基質鐵的吸收率優於植物性食物中的非血基質鐵，所以動物性食物為較好的鐵質來源食物。

食物是最天然、最安全且易吸收的營養補充品，利用天然食物補充鐵質不易產生過量的問題，但對嚴重貧血的病人而言，光靠飲食其實是不夠的，除了攝取含鐵豐富的食物外，還需遵循醫囑補充鐵劑，才能達到最佳的治療效果。

（作者為臺中榮民總醫院營養室營養師）